

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação 10/07/2023	Próxima Revisão 10/07/2025	Versão nº 02	Rotina nº 39	Página 01 à 09
Nome do Procedimento: Acidente de Trabalho e Risco Ocupacional				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais das Unidades de Saúde				
Objetivo: Definir critérios e procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes de trabalho com os servidores municipais.				
Recursos necessários: • Material de expediente; • Computador; • Acesso à internet; • Acesso ao Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saúde Tech); • Acesso ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação; • Formulário de notificação de acidente de trabalho; • Formulário de comunicação de acidente; • Testes rápidos sorológicos.				

CONCEITO

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): Documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou de trajeto.

Acidente de trabalho ou de trajeto: Configura acidente em serviço ou durante o deslocamento do servidor para o trabalho, dentro de sua rota habitual, com dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido, com a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade laborativa.

Acidente por material biológico: Exposição ao sangue e outros fluidos biológicos.

Risco Ocupacional: Qualquer situação que possa expor o profissional a patologias, danos, prejuízos funcional ou emocional ou distúrbios de qualquer espécie. Dúvidas sobre os riscos ocupacionais, entrar em contato com a Unidade de Saúde do Servidor (USS).

DESCRIÇÃO

Acidente de trabalho com material biológico

Deve ser considerado emergência médica, havendo, portanto, necessidade de se priorizar o atendimento no mais curto espaço de tempo possível.

As condutas específicas a serem tomadas visam evitar a disseminação do vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite B (HBV) e vírus da hepatite C (HCV) no ambiente de trabalho. O mais importante é ressaltar sempre as medidas de precaução padrão que deverão ser adotadas quando houver a possibilidade de contato com sangue, secreções, excreções, fluidos corporais, pele não-integra e mucosas.

Cuidados com a área exposta após acidente

- Lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou cutânea;
- Nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica;
- Não há evidência de que o uso de antissépticos ou a expressão do local do ferimento reduzam o risco de transmissão, entretanto, o uso de antisséptico não é contraindicado;
- Não devem ser realizados procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes e injeções locais. A utilização de soluções irritantes como éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio também está contraindicada.

Avaliação do risco da exposição após o acidente

No atendimento inicial após a exposição, será preciso que o profissional avalie como e quando ocorreu a exposição, investigar a condição sorológica da pessoa exposta e da pessoa fonte da infecção, quando houver fonte conhecida. A partir da avaliação desses critérios definir se há ou não indicação de início da profilaxia pós exposição.

A indicação de profilaxia pós-exposição (PEP) requer a avaliação do risco da exposição descritos nos quadros abaixo, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia à Infecção pelo HIV:

- ✓ O tipo de material biológico envolvido;
- ✓ O tipo de exposição;
- ✓ O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento;
- ✓ A condição sorológica para o HIV da pessoa exposta;
- ✓ A condição sorológica da pessoa fonte.

Quadro 01 – Classificação de risco dos materiais biológicos do HIV

Risco de transmissão	Sem risco de transmissão
Sangue, sêmen, secreção vaginal, líquido, tecidos orgânicos, exsudatos inflamatórios, cultura de células, líquido pleural, pericárdico, peritoneal, articular e amniótico.	Suor, urina, fezes, escarro/secreção nasal, vômito, lágrima e saliva. A presença de sangue nestas excretas torna-os infectantes, ou seja, de risco.

Quadro 02 – Tipo de exposição

Percutâneas	Lesões provocadas por instrumentos perfurantes e/ou cortantes (ex: agulhas, bisturis, vidrarias).
Em mucosas	Respingo em olhos, nariz, boca e genitália.
Em pele não-integra*	Contato com pele com dermatite, lesões abertas, mordeduras humanas consideradas como exposição de risco, quando envolverem a presença de sangue.

*Em casos em que houver contato humano direto, tanto o indivíduo que provocou a lesão quanto aquele que foi lesado devem ser avaliados.

Maior inoculação viral

- ✓ Paciente-fonte com HIV/AIDS em estágio avançado;
- ✓ Infecção aguda pelo HIV;
- ✓ Situações com viremia elevada;
- ✓ Deve-se observar, no entanto, que há a possibilidade de transmissão, mesmo quando a carga viral for baixa e quando houver a presença de pequeno volume de sangue.

Orientações e aconselhamento ao acidentado

- ✓ Com relação ao risco a qual está exposto;
- ✓ Possível uso de quimioprofilaxia;
- ✓ Aconselhamento pré e pós teste;
- ✓ Consentimento para realização de exames sorológicos;
- ✓ Comprometer o acidentado com seu acompanhamento durante seis meses;
- ✓ Prevenção da transmissão secundária;
- ✓ Suporte emocional devido ao estresse pós-acidente;
- ✓ Orientar o acidentado a relatar de imediato os seguintes sintomas: linfadenopatia, *rash* cutâneo, dor de garganta, sintomas gripais (sugestivos de soro-conversão aguda);
- ✓ Reforçar a prática de biossegurança e precauções básicas em serviço.

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO- LABORATORIAL

Avaliação sorológica do servidor exposto ao material contaminado

A indicação ou não de PEP dependerá do status sorológico para HIV da pessoa exposta, que deve sempre ser avaliado por meio de testes rápidos (TR) em situações de exposições consideradas de risco:

- ✓ **Amostra não reagente** – teste rápido 1 (TR1) não reagente: a PEP está indicada, pois a pessoa exposta é suscetível ao HIV;
- ✓ **Amostra reagente** – teste rápido 1 (TR1) e teste rápido 2 (TR2) reagentes: a PEP não está indicada. A infecção pelo HIV ocorreu antes da exposição que motivou o atendimento e a pessoa deve ser encaminhada para acompanhamento clínico e início da terapia antirretroviral (TARV);
- ✓ **Amostra com resultados discordantes** – TR1 reagente e TR2 não reagente: não é possível confirmar o status sorológico da pessoa exposta. Recomenda-se iniciar o fluxo laboratorial para elucidação diagnóstica. Nesse caso, a decisão de iniciar ou não a profilaxia deve ser avaliada conforme critério clínico e em conjunto com a pessoa exposta.

Nota: É direito do usuário recusar a PrEP ou outros procedimentos indicados após a exposição, como coleta de exames laboratoriais. Nesses casos, orienta-se o registro em prontuário, com documentação da recusa e explicitação de que no atendimento foram fornecidas informações sobre os riscos da exposição, assim como a relação entre o risco e o benefício das intervenções.

Avaliação sorológica do paciente-fonte

Esse critério é o único não obrigatório, pois nem sempre a pessoa-fonte está presente e disponível para realizar a testagem, ou, em muitos casos, o acidente ocorreu com objetos perfurocortantes contaminados desprezados em locais inadequados, e não há possibilidade de identificar o paciente fonte. Portanto, é fundamental o acolhimento na situação de comparecimento em conjunto aos serviços, a oferta de testagem rápida e as orientações pertinentes.

- ✓ **Amostra não reagente** (TR1 não reagente): a PEP não está indicada. Contudo, a PEP poderá ser indicada para a pessoa exposta quando a pessoa-fonte tiver história de exposição de risco nos últimos 30 dias, devido à possibilidade de resultados falso-negativos de testes imunológicos de diagnóstico (rápidos ou laboratoriais) durante o período de janela imunológica, portanto, a história clínica deve seguir de base para a escolha ou não do início da PEP. No caso de utilização de testes de fluido oral, considerar janela imunológica de 90 dias;
- ✓ **Amostra reagente** (TR1 e TR2 reagentes): a PEP está indicada para a pessoa exposta. Se o status sorológico da fonte era previamente desconhecido, a pessoa-fonte deve ser comunicada individualmente sobre os resultados da investigação diagnóstica e encaminhada para acompanhamento clínico e início da TARV;

- ✓ **Se desconhecido:** avaliar caso a caso.

Notas:

- Não se deve atrasar e nem condicionar o atendimento da pessoa exposta à presença da pessoa-fonte;
- Deve-se levar em consideração a gravidade da exposição e a probabilidade clínica e epidemiológica de infecção pelo HIV naquela exposição (área de alta prevalência para HIV, pacientes internados com infecção pelo HIV naquele ambiente etc.). Existem muitos casos em que a PEP não está indicada, em função do risco extremamente baixo de transmissão do HIV.

Primeiro Atendimento

- ✓ Servidor deverá ser encaminhado e atendido como prioridade (emergência) na UPA/PA 24h mais próxima ao local de acidente, para a investigação da exposição (Classificação de Risco);
- ✓ Deve ser atendido por médico plantonista, que irá avaliar o risco do acidente, história clínica e solicitar exames. O médico deve preencher o prontuário eletrônico no SIG-Saúde Tech com os seguintes CIDs:
 - **Y96** – Circunstância relativa às condições de trabalho
 - **Z57.8** – Exposição ocupacional a outros fatores de risco
- ✓ Os exames a serem realizados (testes rápidos): HCV, sífilis, HbsAg (Antígeno de superfície da Hepatite B) e HIV para todos os acidentes com material biológico;
- ✓ Em caso de prescrição de PEP, deve-se solicitar exames laboratoriais complementares: hemograma, TGO (transaminase glutâmico oxalacética), TGP (transaminase glutâmica pirúvica), bilirrubina direta e indireta, ureia, creatinina, anti HBS (Anticorpo contra o antígeno de superfície da Hepatite B) e glicemia;
- ✓ Se houver indicação de PEP, o servidor receberá medicação para 28 dias logo após a consulta médica;
- ✓ Após atendimento, o servidor deverá preencher o formulário da CAT, anexar ao Processo SEI (Comunicado de Acidente de Trabalho) e encaminhar para SGP.USS.AAD para agendamento conforme descrito no item 2;
- ✓ A Ficha de Notificação (Anexo 1) deve ser preenchida pelo enfermeiro ou médico responsável pelo atendimento e encaminhada para a Vigilância Epidemiológica (entregar para a chefia da UPA ou PA 24 h, para envio junto com os demais documentos da Unidade.

A Notificação é de extrema importância, para que se possa acompanhar os casos e atuar na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, por meio de ações de Vigilância.

Quadro 03 – Esquema Preferencial

Medicação	Dose	Intervalo
Tenofovir + Lamivudina (TDF/3TC) 300mg/300mg	01 Comprimido	01 vez ao dia
Dolutegravir (DTG) 50mg	01 Comprimido	01 vez ao dia

Quadro 04 – Esquema preferencial para pessoas em uso de rifampicina, carbamazepina, fenitoína ou fenobarbital

Medicação	Dose	Intervalo
Tenofovir + Lamivudina (TDF/3TC) 300mg/300mg	01 Comprimido	12/12 horas
Dolutegravir* 50mg (DTG)	01 Comprimido	12/12 horas

*O **dolutegravir** não está recomendado em pessoas que façam uso de dofetilida e pilsicainida. Nesses casos, o ATV/r é a medicação alternativa. O **dolutegravir** aumenta a concentração plasmática da metformina, cabendo especial atenção a pacientes diabéticos.

Quadro 05 – Esquema preferencial para Gestantes e mulheres com potencial de engravidar

Até 12 semanas de gestação ou tentando/potencial de engravidar		
Medicação	Dose	Intervalo
Tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) 300mg/300mg	01 Comprimido	01 vez ao dia

Quadro 06 – Esquema preferencial

Após 12 semanas de gestação		
Medicação	Dose	Intervalo
Tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) 300mg/300mg	01 Comprimido	01 vez ao dia
Dolutegravir (DTG) 50mg	01 Comprimido	01 vez ao dia

Orientação para Hepatite

- ✓ Solicitar teste rápido de HBV (HbsAg) do paciente-fonte quando possível;
- ✓ Solicitar teste rápido de HBV (HbsAg) e Anticorpo contra o antígeno de superfície da Hepatite B (Anti- HBs) do servidor.

Quadro 07 – Resultado teste rápido e conduta

Resultado Teste Rápido	Conduta
Paciente-fonte reagente e servidor não imune (Anti-HBs negativo)	• Gamaglobulina (imunoglobulina hiperimune anti-HBV 0,06ml/kg de peso); • Vacina anti- HBV (3 doses).
Paciente-fonte positivo e anti-Hbs do servidor positivo	• Fazer acompanhamento sorológico.
Paciente-fonte negativo e anti-Hbs do servidor negativo	• Vacina anti- HBV (3 doses); • Fazer acompanhamento sorológico.
Paciente-fonte negativo e anti-Hbs do servidor positivo	• Fazer acompanhamento sorológico.

Segundo atendimento

- ✓ Após 15 dias de exposição, consulta médica para acompanhamento sorológico na UBSF;
- ✓ Se o servidor estiver em uso de PrEP, solicitar exames laboratoriais (hemograma, TGO, TGP, bilirrubina direta e indireta, ureia, creatinina e glicemia).

Seguimento

Consulta de enfermagem para acompanhamento sorológico (coordenador agenda na UBSF de referência do servidor):

- ✓ 40 DIAS após a exposição, realizar testes rápidos (sífilis, HBSAg e HIV);
- ✓ 3 MESES após a exposição, realizar testes rápidos (sífilis, HBSAg e HIV)
- ✓ 6 MESES após a exposição, realizar teste rápido (HCV);
- ✓ Se o servidor trabalhar em Unidade que tenha profissional de saúde capacitado para realizar os testes rápidos e solicitar os exames laboratoriais (médico, enfermeiro), o acompanhamento assistencial pode ser realizado na própria Unidade até o encerramento do caso, isto é, após o 6º mês do acidente.

Atendimento Especializado

Em casos de sorologias ou testes rápidos reagentes e em situações de reações adversas persistentes ao uso de PrEP, entrar em contato com a Unidade de Assistência Especializada (UAE) (telefone: 3417-1377, segunda-feira a sexta-feira, das 07:30 às 18:30).

Acompanhamento Laboratorial

Todos os servidores que necessitem realização de exames laboratoriais para acompanhamento da PEP devem ser agendados para coleta de sangue SOMENTE no Laboratório Municipal, via SIG – Saúde Tech. Caso não houver vaga que contemplem o dia necessário para realização dos exames, solicitar agendamento de urgência, pelo e-mail: olos.laboratorios@gmail.com.

Resultado de exames

Devem ser digitalizados e encaminhados para a Unidade de Saúde do Servidor no seguinte e-mail: enfermagemdotrabalho@joinville.sc.gov.br para realização de monitoramento da exposição ocupacional.

Nota:

Mais informações podem ser encontradas no [Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para profilaxia pós-exposição \(PrEP\) de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais](#) e Apêndice 01.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais**. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET). **Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho com Material Biológico**. Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/images/DRT/DRT_Acidente_Trabalho_Biologico.pdf. Acesso em 18/10/2021.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET). **Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho Grave**. Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/images/DRT/DRT_Acidente_Trabalho_Grave.pdf. Acesso em 18/10/2021.
4. Prefeitura de Joinville. Secretaria de Gestão de Pessoas. Unidade de Saúde do Servidor. **Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)**. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Formul%C3%A1rio-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-de-Acidente-de-Trabalho-CAT.pdf>. Acesso em 15/10/2021.
5. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gerência de Vigilância em Saúde. INTRANET Saúde. **Nota informativa n 01/2018 GVS/SAE**.
6. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gerência de Vigilância em Saúde. INTRANET Saúde. Nota informativa nº 02/2018 GVS/SAE. **Referente ao uso do Dolutegravir para Profilaxia Pós Exposição em Mulheres em Idade Fértil**. Disponível em: https://intranetsaude.joinville.sc.gov.br/publicador_documentos/documentos/arquivos/6706.pdf. Acesso em 21/10/2021.
7. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gerência de Vigilância em Saúde. INTRANET Saúde. Nota técnica nº 01/2017 GVS/SAE. **Recomendações para a Profilaxia da infecção pelo HIV, IST e Hepatites B e C, em situações de exposição sexual e por material biológico no Município de Joinville**. Disponível em: https://intranetsaude.joinville.sc.gov.br/publicador_documentos/documentos/arquivos/6703.pdf. Acesso em 30/09/2021.

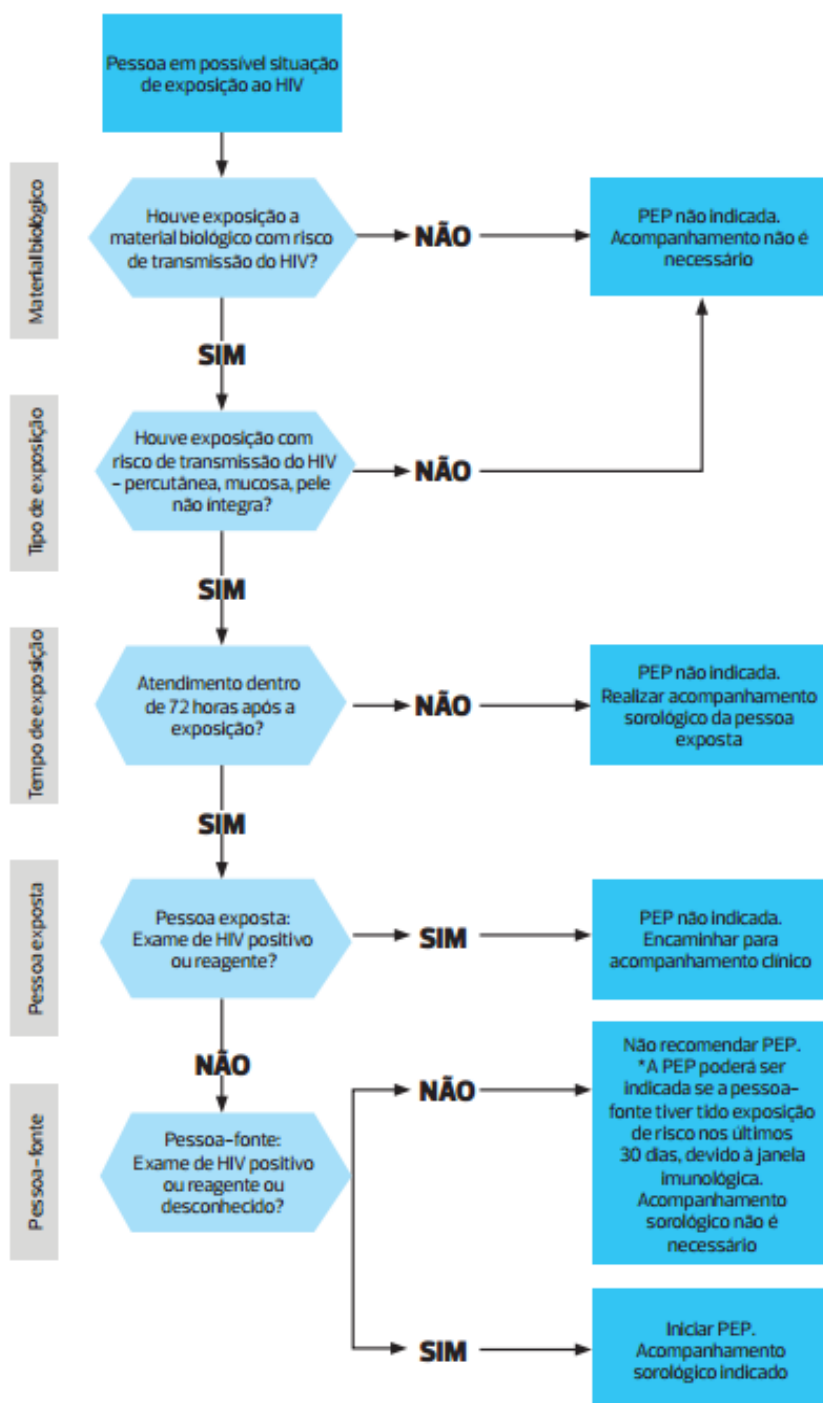


Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área: Saúde

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2023	Fabiane Cherobin	• Inclusão do fluxograma para indicação de PEP ao HIV; • Inclusão da avaliação sorológica do servidor exposto ao material contaminado; • Inclusão da avaliação sorológica do paciente-fonte.

Apêndice 01 – Fluxograma para indicação de PEP ao HIV



ANEXO 1 – Comunicação de acidente de trabalho

		Prefeitura Municipal de Joinville Secretaria de Gestão de Pessoas Unidade de Saúde do Servidor			
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT					
Dados do servidor acidentado					
1. Nome:					
2. Matrícula	3. Data nascimento:	4. Sexo: () masculino () feminino	5. Estado civil: () solteiro () casado () divorciado () separado () viúvo () união estável	6. Escolaridade () fundamental inc. () fundamental () médio inc. () médio () técnico () superior inc. () superior () pós graduação	
7. Regime de trabalho () estatutário () estatutário especial () estagiário	8. Cargo/função:	9. Tempo de serviço:		11. Local de trabalho:	
		10. Tempo na função:			
Dados do acidente					
12. Data do acidente:		13. Hora do acidente:		14. Local do acidente/endereço:	
15. Houve atendimento médico? () sim () não		16. Unidade de atendimento médico?			
17. Descrição do acidente:					
18. Assinatura e matrícula da chefia imediata			19. Assinatura e matrícula de testemunha		
Segurança do Trabalho					
20. Causas apuradas			21. Agente causador: () ambiental () mecânico () pessoal () organizacional		
			22. Parte do corpo atingido:		
			23. Tipo de Acidente: () típico () trajeto () necessita parecer médico () não caracterizado acidente de trabalho		
24. Data	25. Assinatura e carimbo		26. Assinatura do servidor acidentado		
Medicina do Trabalho					
27. Houve internação: () sim () não	28. Tempo de afastamento?	29. Tipo de lesão:		30. CID - 10 (lesão):	
31. CID – 10 (causa externa):		32. Caracterização da doença: () profissional () do trabalho () não há nexos causal			
33. Data	34. Assinatura e carimbo do médico:				

1ª via prontuário médico

2ª via segurança do trabalho

3ª via servidor

Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Formul%C3%A1rio-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-de-Acidente-de-Trabalho-CAT.pdf>

